Pacient 9 r.č. 923456/9999 poj.

tel.

Propouštěcí zpráva

Hospitalizace: 6 dní

RA: Matka DM na inzulinu, matka DM na PAD, otec matky + v 64 na TBC **OA:** HT, DM II na dietě, 12.1. - zavedení JJ stentu bilat., Operace: stp. Open laparoscopy, exploratio, biopsia hepatis

EA: Za posledních 14 dní nebyla v kontaktu s infekčním onemocněním.

SA:

PA: Vedená ÚP

FA: Anopyrin - naposledy 1.2., Nitresan 10 1/2-0-1/2, Telmisartan 80 1-0-0, Detralex 1-0-1, Fraxiparin 0,3ml s.c. v 17:30, Sorbifer 1-0-0

GA: G1/P1/U0 - 1xSZ, menopauza v 51, od té doby nekrvácela, gyn. op.: viz výše

Abusus: Sine

ALERGIE: neguje

Nynější onemocnění:

pacientka přijata k plánovanému operačnímu výkonu (LT HE + AE bilat + FS) pro nález v dutině břišní. Subj.: od operace bolesti povolily, jinak bez obtíží

Status praesens:

Pacientka orientovaná, aniktericka, bez klidové dušnosti, bez známek cyanózy, přiměřené výživy a hydratace. HLAVA:zornice isokorické, sklery aniktericke KRK: štítna žláza nezvětšena, náplň žil nezvětšená HRUDNÍK: symetrický, dýchaní klidné BŘICHO: měkké prohmatné, nebolestivé, bez hmatné rezistence Dolní končetiny bez otoků, varixů a trofických změn.

Gyn. vyšetření:

INDIKAČNÍ VYŠETŘENÍ, ONKOGYNEKOLOGICKÉ KONZÍLIUM

- *SONOGRAFIE (transvag. + transabdom.)*

VAG: Děloha v AVF, velikosti 119x63x42mm, myomatozní, endometrium 6mm, hypoechogenní, hůře přehledné, přiměřené vaskularizace, ohraničené od myometria, EMJ se jeví ostrá, myometrium nehomogenní, několik drobných myomů v ZS i PS, akustické stíny, CS 1, děložní hrdlo homogenní, přiměřené vaskularizace, seróza hladká, **děloha v konvolutu s adnexálními lézemi až obraz frozen pelvis, za dělohou z oblasti pravých adnex nepravidelná cysticko-solidní léze velikosti 95x68x83mm, počet lokularit 1, solidní složka CS 4, obdobná léze vlevo velikosti 113x65x70mm.**
Orgány pánve omezeně pohyblivé, močový měchýř hladký, **dist. uretery se zavedenými stenty, vpravo ureter infiltrován pravou adnexální lézí, levý ureter lézi podbíhá, rektum a rektosigmoideum bpn**, **v malé pánvi spoře volné tekutiny**, serózy hladké, nástěnné i viscerální peritoneum bez patologického nálezu, bez retroperitoneální lymfadenopatie.
ABD: játra homogenní - v **S VII hemangiom**, žlučník bpn, **parakolické prostory vlevo i vpravo s difusní karcinomatozou 4mm, vpravo dilatace KPS gr. III**, vpravo bez dilatace, slezina bez postižení, peritoneum bpn, lymfatické uzliny v retroperitoneu bez postižení. **Omentum šíře 9mm. Ascites.**
Ré - Ascites, adenxální cysticko-solidní léze, susp. maligní (vpravo infiltruje ureter) difuzní karcinomatóza parakolicky bilaterálně
Dilatace KPS gr. III - st.p. inzerci JJ stentů

- *Rtg S+P* - bez ložiskového nálezu

- *Onkomarkery* Ca 125: 7380, Ca 19-9: 7845, Ca 72-4: nad 250

- *CT hrudníku a břicha (nativ + ultravist 370) 2026:*
Z : Masivní TU masy MP vs ovarial. TU. s útlakem ureterů distalně (sekunadní akcentuace ureterů kranialněši mírna dilatace DS ledviny bilat.) bez eviden. distant. mts. do břišních a hrudních organů

- *Biopsie dutiny břišní* - fragment fibrózního stromatu bez maligních struktur.

- ***Open laparoscopy, exploratio, biopsia hepatis***
Operační nález: malá pánev zcela překryta oboustrannými, hladkými tumory ovarií velikosti 10-12 cm každý, které adherují k sobě navzájem, k děloze a velmi intimně i k rektosigmoideu kdy nelze vyloučit infiltraci střeva, peritoneální povrchy v celé dutině břišní bez ložiskových změn, není známek karcinomatosy a šíření neoprocesu,

poj.
tel.

Propouštěcí zpráva - pokračování

omentum, tenké střevní kličky, žaludek i brániční klenby bpn., z povrchu jater pod lig. teres hepatis prominuje asi 1 cm léze - v.s. hemangiom. Volná tekutina v dutině bišní v minimálním rozsahu periheptálně, jantarový výpotek.

- *Koloskopie 2026*: Úplná koloskopie. Nekvalitní příprava. Zevní útlak v oblasti rektosigmatu kolem 15cm od anu, lumen ale zcela volně průchodné, na sliznici bez známek nádoru.

Nález při přijetí idem.

Konzilia/paraklinika:

Lab. nález z 26:

Ionty:
Sodík_S/P: 142 mmol/L [137 ... 145], Draslík_S/P: 4,9 mmol/L [3,5 ... 5,1], Chloridy_S/P: 104 mmol/L [97 ... 108]
Renální funkce:
Urea_S/P: 6,6 mmol/L [3,1 ... 7,9], Kreatinin_S/P: 78 µmol/L [46 ... 92], eGF z kreatininu_Q: 1,25 mL/s [1,00 ... 2,35]
Jaterní funkce:
ALT_S/P: 0,23 µkat/L [0,17 ... 0,75], AST_S/P: **0,19** µkat/L [0,25 ... 0,58]
Diabetes mellitus:
Glukóza_S/P: 5,45 mmol/L [3,60 ... 5,59]
Markery zánětu:
C reaktivní protein_S/P: **40,8** mg/L [0,0 ... 5,0]
Specifické proteiny:
Celková bílkovina_S/P: 62,8 g/L [62,0 ... 78,0], Albumin_S/P: **34** g/L [35 ... 52]
Moč chemicky + sediment:
pH_chemicky +sediment_U: 5,5 - [5 ... 7], Krev_U: +-, Leukocyty_U: **1** arb.j. [0 ... 0], Nitrity_U: 0 arb.j. [0 ... 0], Bílkovina_U: +-, Glukóza_U: 0 arb.j. [0 ... 0], Ketolátky_U: 0 arb.j. [0 ... 0], Urobilinogen_U: 0 arb.j. [0 ... 0], Bilirubin_U: 0 arb.j. [0 ... 0], Specifická hustota_U: 1,014 kg/m^3 [1.01 ... 1.03], Barva moče_U: žlutá, Zákal moče_U: čirá, Erytrocyty_U: **108** 10^6/L [0 ... 5], Leukocyty _U: **15** 10^6/L [0 ... 10], Epitelie dlaždicové_U: 4 10^6/L [0 ... 15], Epitelie přechodné_U: 6 10^6/L [0 ... 10], Válce hyalinní_U: 0 10^6/L [0 ... 2], Bakterie_U: **2** arb.j. [0 ... 0], Bakterie tyčinky_U: 4 10^6/L [0 ... 100], Bakterie koky_U: **377** 10^6/L [0 ... 100]
Krevní obraz:
Leukocyty: 7,09 10^9/L [4,00 ... 10,00], Neutrofily_analyzátor: 49,8 % [45 ... 70], Lymfocyty_analyzátor: 34,6 % [20 ... 45], Monocyty_analyzátor: 7,5 % [2 ... 12], Eozinofily_analyzátor: **7,3** % [0 ... 5], Bazofily_analyzátor: 0,8 % [0 ... 2], Neutrofily-absolutní počet: 3,53 10^9/L [2,00 ... 7,00], Lymfocyty-absolutní počet: 2,45 10^9/L [0,80 ... 4,00], Monocyty-absolutní počet: 0,53 10^9/L [0,08 ... 1,20], Eozinofily_absolutní počet: **0,52** 10^9/L [0,00 ... 0,50], Bazofily_absolutní počet: 0,06 10^9/L [0,00 ... 0,20], Erytrocyty: **3,71** 10^12/L [3,80 ... 5,20], Hemoglobin: **113** g/L [120 ... 160], Hematokrit: **0,328** - [0,350 ... 0,470], MCV: 88 fL [82 ... 98], RDW: 13,8 % [10 ... 15.2], Trombocyty: 347 10^9/L [150 ... 400], MPV: 9,7 fL [7,8 ... 12,8], MCH: 31 pg [28 ... 34], MCHC: 345 g/L [320 ... 360]

Histologie:

peroperační histologie: levé ovarium bez malignity, v pravém ovariu serozní karcinom spíše low grade.
definitivní histologie není t.č. k dispozici

Přehled terapie:

AZEPO, INJ/INF PLV SOL, 1G; METRONIDAZOL B. BRAUN, INF SOL, 5MG/ML; AGEN, TBL NOB, 5MG; DETRALEX, TBL FLM, 500MG; INDOMETACIN BERLIN-CHEMIE, SUP, 50MG; NITRESAN, TBL NOB, 10MG; NOVALGIN, TBL FLM, 500MG; PARALEN, TBL NOB, 500MG; SORBIFER DURULES, TBL MRL, 320MG/60MG; SUPPOSITORIA GLYCERINI IPSEN, SUP, 1,81G; TELMISARTAN EGIS, TBL FLM, 80MG; DORMICUM 7.5MG TBL.OBD.10X7.5MG; DITHIADEN, INJ SOL, 0,5MG/ML; NOVALGIN, INJ SOL, 500MG/ML; PLASMALYTE, INF SOL(); DIPIDOLOR, INJ SOL, 7,5MG/ML; CLONIDINE OLIKLA, INJ SOL, 150MCG/ML; FRAXIPARINE, INJ SOL ISP, 9500IU/ML; NOVALGIN, INJ SOL, 500MG/ML; PARACETAMOL KABI, INF SOL, 10MG/ML; TORECAN, INJ SOL, 6,5MG/ML

Operace:

2026 - PDS - hysterectomia cum adnexectomia bilateraliá, omentectomia, apendectomia, stripping peritonei pelvici, lymfadenectomia pelvis et paraaortalis
Nález peroperační: dutina břišní bez volné tekutiny, obě ovaria změněná v 10cm cystické tumory hladkého povrchu v pevných adhézích navzájem, k děloze a rektosigmoideu. Nástěnné i viscerální peritoneum bez ložiskového nálezu, jako i kličky střevní a mesenterium, apendix klidný, povrch jater a bránice hladký. Uzliny retroperitonea nezvětšené. Peroperačně z drobné perforace odchází hlen z levého i ovariálního tumoru.

UPV: Ne

Průběh hospitalizace:

pacientka přijata k operačnímu řešení pro nález v dutině břišní. Operace (viz výše) a pooperační období bez komplikací, pacientka po celou dobu hospitalizace kardiopulmonálně kompenzována, afebrilní, aperitoneální,

poj.
tel.

Propouštěcí zpráva - pokračování

operační rány hojeny primárně, bez zánětlivých změn v okolí, neresorbovatelné svorky in situ. Propuštěna v celkově stabilizovaném stavu, bez subjektivních potíží,vaginálně nekrvácí, mikce bez dysurie, střevní pasáž bez poruchy. UZ před dimisí bez patologického nálezu.

Diagnostický souhrn:

Carcinoma ovarii dle FS
Stp.laparoscopiam explorativa, biopsia hepatis 2/26
- z biopsie jater kavernózní hemangiom
JJ stent bilat.
Hypertenze
DM II na dietě

Doporučení:

Pacientka propuštěna do ambulantní péče. Doma klidový režim, zvýšená hygiena, analgetika dle potřeby. Extrakce svorek 10.- 12. pooperační den cestou praktického lékaře nebo gynekologa, možno

K prvnímu cyklu chemoterapie se dostaví na chemostacionář, večer předem užije Dexamethason 20mg tbl v vezme lék Zyrtec 10mg (recepty na léky zaslány SMS) Pokračovat v užívání medikace, viz níže. Při potížích kontrola u nás kdykoliv.

Doporučená medikace:

FRAXIPARINE, INJ SOL ISP, 9500IU/ML, 0,4ml, s.c., (Rp. na 10 injekcí, další preskripci prosím cestou PL) - ;
NITRESAN, TBL NOB, 10MG, p.o., 1/2 - 0 - 1/2;
TELMISARTAN EGIS, TBL FLM, 80MG, p.o., 1-0-0;
DETRALEX, TBL FLM, 500MG, p.o., 1-0-1;
SORBIFER DURULES, TBL MRL, 320MG/60MG, p.o., 1-0-0 (Rp.SMS).